

輸液ポンプの危険



その1



生命にかかわるフリーフロー： クレンメを全開にして点滴を落とす、一気注入のこと

どのような状況で発生するか？

- ・あわててポンプから輸液ラインを外すとき
- ・着替え、移動などで、ラインをポンプから外すとき
- ・MRI検査などで、ポンプを外すとき

ポンプからラインを外すときはクレンメを必ず閉じる
これは、条件反射的にできるように訓練が必要！！

その2



クレンメを閉鎖したまま開始を押して「閉塞アラーム」、あわてて開放は危険

ラインが閉塞している状態は、薬液を押し込もうとするポンプの力でポンプと閉塞部位のラインの内圧が高くなる。この状況で、いきなり閉塞を解除すると、その内圧により薬液が急速注入される。

ラインの内圧の逃がし方

- ①クレンメを患者側まで移動させクランプする。
- ②輸液ポンプのチューブクランプを解除し圧を点滴筒側に逃がす。
- ③ラインをポンプに再セットして、ポンプのドアを閉じた後、クレンメを開放する。

その3



複数ポンプ、複数ライン使用時の危険

- ・複数ポンプ使用時の、同時輸液更新では、輸液の取り違えに注意

ボトル・ポンプの取り違え、ラインの交差に注意する。指差呼称で必ずラインをたどって更新する。

- ・微量注入ラインからの、他の薬剤のワンショット注入は急速注入の危険

微量で注入されている危険薬剤のラインの途中から、ワンショットで側注すると、その部位から針先までのライン内の薬剤を急速に押し入れることになり危険。

- ・ポンプをつけたラインと、自然落下のラインとの併用の危険

接続部位より抹消でラインの閉塞が起こったとき、ポンプラインの薬液は、自然落下のラインに逆流していくので、閉塞警報がすぐに鳴らず、発見が遅れる。

その4



点滴漏れに注意 **ポンプは注入し続けるので、自然滴下の点滴より重症の漏れに発展する。**

漏れによる痛みを訴えられない乳幼児、意識障害のある患者には、より注意する。